

01 · Strategia della Campagna

Conosci la FMD — Campagna Italiana sulla Displasia Fibromuscolare

1. Visione

Un'Italia in cui la Displasia Fibromuscolare (FMD) sia ****conosciuta, riconosciuta e tempestivamente diagnosticata****, e in cui ogni persona che ne è affetta — insieme alla propria famiglia — trovi cure adeguate, sostegno sociale e serenità.

2. Missione

Costruire consapevolezza pubblica e professionale sulla FMD in Italia, sostenere il suo pieno inserimento nei percorsi di tutela delle malattie rare e creare una comunità di sostegno per pazienti e familiari, nel pieno rispetto della privacy e della dignità delle persone.

3. Il problema in breve

- La FMD è **poco conosciuta**, anche tra i professionisti sanitari non specialisti.
- Ciò comporta **diagnosi tardive o errate** (spesso dopo anni e molti accertamenti).
- I pazienti vivono **incertezza, ansia e isolamento**; le famiglie ne condividono il peso.
- Mancano, in Italia, campagne divulgative strutturate e in lingua italiana.

4. La soluzione: il modello FMDSA adattato all'Italia

La **Fibromuscular Dysplasia Society of America (FMDSA)**, nata nel 2003, ha dimostrato

cosa può ottenere l'advocacy dei pazienti:

- ha promosso e finanziato un **registro dei pazienti** (oggi North American Registry for FMD, presso la University of Michigan) con **oltre 5.000 pazienti** e più di 20 centri;
- ha **ispirato la nascita di cliniche/centri di riferimento** per la FMD;
- ha **finanziato la ricerca** (numerosi pubblicazioni e comunicazioni scientifiche);
- ha ricevuto riconoscimenti come il Global Genes Rare Champion of Hope Award (2020).

L'Italia parte da basi reali su cui costruire:

- dal **2017** esiste un **Registro Italiano (ITA-FMD)**, integrato nel Registro Europeo/Internazionale della FMD, con più centri sul territorio;
- esiste un **quadro normativo delle malattie rare** (Legge 175/2021, Piano

Nazionale

Malattie Rare 2023-2026, LEA, esenzioni) su cui fare leva.

Questa campagna **collega** consapevolezza pubblica e strumenti già esistenti, orientando pazienti e medici verso i canali corretti.

La campagna è ****indipendente****. Cita FMDSA e il Registro Italiano come modello e risorsa, senza rappresentarli né parlare a loro nome, salvo accordi formali.

5. Pubblici di riferimento (target)

Pubblico	Bisogno	Cosa vogliamo che faccia
Persone con FMD (soprattutto donne adulte)	Informazione affidabile, comunità	Cercare i centri di riferimento, sentirsi meno sole
Familiari (partner, figli, genitori)	Capire la malattia, sostenere il	Informarsi, partecipare,
Persone con sintomi non spiegati	Un nome per i propri sintomi	Parlarne col medico, chiedere accertamenti mirati
Medici di medicina generale	Sospetto diagnostico precoce	Riconoscere i segnali, indirizzare ai centri
Media e opinione pubblica	Storie e dati credibili	Dare visibilità alla causa
Istituzioni sanitarie (Regioni, ASL, Ministero)	Dati e voce dei pazienti	Rafforzare tutele e percorsi dedicati

6. Messaggio centrale

****La Displasia Fibromuscolare esiste, ha un nome e si può affrontare.**** Conoscerla significa diagnosi più rapide, cure migliori e serenità per i pazienti e le loro famiglie. ***Conosci la FMD.***

(Le declinazioni operative sono in [02-messaggi-chiave.md](#).)

7. Canali

1. Sito web / landing page — punto di riferimento informativo (vedi [sito/index.html](#)).

2. Social media — Facebook e Instagram come canali primari (community di pazienti già attive lì), più LinkedIn per il dialogo istituzionale (vedi [04-social-media.md](#)).

3. Materiali scaricabili — schede informative, locandine per ambulatori e farmacie.

4. Media relations — comunicati e storie per stampa locale e testate di settore (es. Osservatorio Malattie Rare).

5. Rete di ambulatori e associazioni — diffusione tramite medici di base, farmacie, associazioni di malattie rare (es. UNIAMO, Cittadinanzattiva).

8. Fasi e calendario (12 mesi, adattabile)

Fase	Periodo	Obiettivo	Azioni chiave
0 · Preparazione	Mesi 1-2	Basi solide e conformi	Validazione medica dei contenuti; pubblicazione informativa privacy; identità visiva; sito
1 · Lancio	Mesi 3-4	Farsi conoscere	Comunicato stampa; primi post; coinvolgimento di
2 · Educazione	Mesi 5-8	Informare a fondo	Serie di contenuti sui sintomi/diagnosi; webinar con specialisti; materiali per ambulatori
3 · Advocacy	Mesi 9-10	Rafforzare le tutele	Lettere a istituzioni e Regioni; dialogo con reti malattie rare
4 · Comunità	Mesi 11-12	Consolidare il sostegno	Gruppo di supporto moderato; raccolta (facoltativa e consensuale) di testimonianze; bilancio e rilancio

Date simbolo da presidiare:

- **Ultima settimana di febbraio** — Giornata delle Malattie Rare (Rare Disease Day).
- **Maggio** — mese di sensibilizzazione internazionale sulla FMD (FMD Awareness).
- **29 settembre** — Giornata Mondiale per il Cuore (per i temi cardiovascolari correlati).

9. Indicatori (KPI)

- **Portata:** persone raggiunte, visitatori del sito, copertura media.
- **Coinvolgimento:** iscritti alla newsletter (con doppio opt-in), interazioni social, download dei materiali.
- **Impatto sull'orientamento:** click verso pagine dei centri di riferimento e del Registro Italiano; richieste di informazioni.
- **Advocacy:** numero di istituzioni/associazioni coinvolte, adesioni, risposte ricevute.

I KPI si misurano con ****dati aggregati e anonimi****. Nessun tracciamento invasivo: vedi ``privacy/linee-guida-dati.md``.

10. Risorse e ruoli minimi

- **Referente campagna** — coordina attività e calendario.
- **Referente medico-scientifico** — valida i contenuti clinici.
- **Referente privacy/dati** — presidia la conformità GDPR (vedi cartella [privacy/](#)).
- **Referente comunicazione** — gestisce social, sito e media.
- **Volontari/ambasciatori** — diffondono i materiali seguendo le linee guida.

11. Rischi e mitigazioni

Rischio	Mitigazione
Informazioni mediche imprecise	Validazione da parte del referente medico prima di ogni pubblicazione
Falsa impressione di consiglio medico	Disclaimer costante; rinvio a medico e centri
Violazione della privacy dei pazienti	Consenso esplicito, minimizzazione, informativa
Uso improprio di testimonianze	Consenso scritto revocabile; anonimizzazione su richiesta
Appropriazione dell'identità di terzi (FMDSA, medici)	Nota di indipendenza; citazioni corrette; accordi formali dove previsto

Prossimo documento: `02-messaggi-chiave.md`.